我的青光眼需要加強治療，有哪些選擇？

醫病共享決策輔助工具

基隆長庚紀念醫院 眼科部 病歷號：_____

姓名：_____

填寫人：☐ 本人 ☐ 家屬（關係：　　）

日期：_____

模組一：要加第二種眼藥水，還是試試雷射（SLT）？

一、先了解一下

青光眼是視神經慢慢受損的疾病，**已經失去的視力無法恢復**。治療目標是把眼壓降到安全範圍，讓惡化停下來。

您目前用一種眼藥水，但眼壓還不夠低（或藥水讓您不舒服）。下一步有兩種方式：

	選項 A **再加一種眼藥水**	**選項 B** **選擇性雷射小樑成形術（SLT）**
怎麼做	每天多點一種藥，或改用複方藥水	門診雷射，約 10 分鐘，不用開刀
降壓效果	通常可再降一些	約七到八成的人有效， 但已在點藥的眼睛， 效果通常比第一次治療就做時小
效果能維持多久	持續點就持續有效	效果會隨時間減弱，數年後常需要重做；**可以重複做**
每天的負擔	點藥次數增加，容易忘記	不增加點藥； 部分人之後有機會少點一種
常見副作用	依藥物不同：眼紅、刺痛、乾澀， 部分藥物會影響心跳或呼吸	雷射後幾天眼睛酸、輕微發炎、 短暫眼壓升高

	選項 A 再加一種眼藥水	選項 B 選擇性雷射小樑成形術（SLT）
之後還能做其他治療嗎	可以	可以，不影響之後用藥或手術
費用	健保	健保

兩種方式本院都是健保給付，選擇時可以不用考慮費用，依您的生活習慣與感受決定即可。

重要： 不論選哪一種，都需要規律回診量眼壓、追蹤視野。SLT 不是「做完就好了」。

二、對您來說，什麼比較重要？

1. 每天點眼藥水，對您來說有多麻煩？

☐ 很麻煩，常忘記或覺得困擾　☐ 還可以　☐ 完全沒問題

2. 目前的眼藥水讓您不舒服嗎？（眼紅、刺痛、乾澀等）

☐ 很不舒服　☐ 有一點　☐ 沒有

3. 您是否有心臟、氣喘或其他慢性病，需要同時吃很多藥？

☐ 有　☐ 沒有　☐ 不確定

4. 比起每天多點一種眼藥水，您是否願意到門診做一次雷射？

☐ 願意　☐ 視情況，想再了解　☐ 不願意，比較想點藥

系統參考方向（不直接建議）：

第 1、2 題偏「麻煩／不舒服」、第 3 題為「有」，或第 4 題「願意」 ➡ 提示「SLT 可能較符合您的需求」

第 4 題「不願意」且第 1、2 題皆無困擾 ➡ 提示「加藥可能較符合您的需求」

三、確認一下您的了解

5. 做完 SLT 雷射後，就不需要再回診追蹤了。

☐ 對　☐ 不對　☐ 不確定

答題後顯示：**不對。** 雷射效果會慢慢減弱，仍需要定期量眼壓、檢查視野。

6. 青光眼已經失去的視力，治療後可以恢復。

☐ 對　☐ 不對　☐ 不確定

答題後顯示：**不對。** 治療的目的是保住現有視力，不是讓視力變好。

四、我的選擇與確認

7. 我目前傾向：

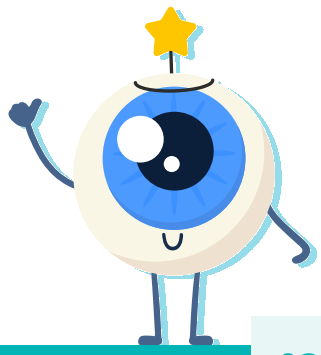
☐ 再加一種眼藥水　☐ 先試試 SLT 雷射　☐ 還沒決定，想再和醫師討論

8. 我對自己的選擇有把握　☐ 是 ☐ 否

9. 我了解每個選項的好處和缺點　☐ 是 ☐ 否

10. 我清楚哪些事情對我最重要　☐ 是 ☐ 否

11. 我有足夠的支持和建議來做決定　☐ 是 ☐ 否



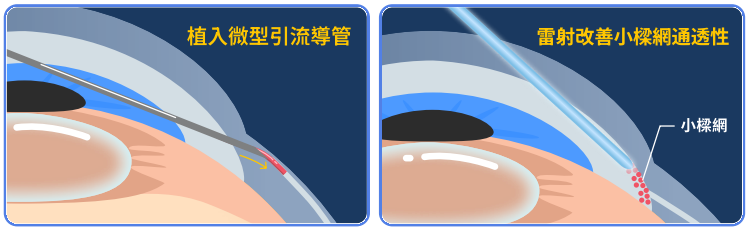
模組二：要再加最後一種藥，還是考慮手術？

一、先了解一下

您已經使用多種眼藥水，眼壓還是不夠低（或青光眼仍在惡化）。這時有兩條路：

- **繼續加藥：**可以再加一種點藥或口服藥，但藥越多，副作用、花費、忘記點的機會都會增加，而且通常已經接近藥物能達到的極限
- **接受手術：**做一條新的排水通道，把眼壓降得更低，很多人術後可以減少或停用眼藥水

若您之前沒做過 SLT： 部分病人在這個階段仍可考慮先做雷射（健保給付），請與醫師討論。
若您同時有白內障需要處理： 可能有「白內障手術合併微創支架」的選擇，醫師會另外說明。
若病情較複雜： 可能需要引流管植入手術，本院會協助轉介。



	選項 A 再加最後一種藥	選項 B XEN 凝膠支架（自費）	選項 C 小樑網切除術（健保）
怎麼做	再多一種點藥或口服藥	手術室局部麻醉，植入極細的引流管	手術室麻醉，在眼球壁做新的排水通道
降壓效果	有限， 可能仍無法達到目標	明顯降低 (研究中三年約降 35%)	**最強** (研究中三年約降 50%)
之後還要點藥嗎	需要，而且種類最多	多數人可大幅減藥	較多人可以完全停藥
恢復與回診	依原本追蹤	恢復較快， 前三個月回診較密	前三個月回診最密集， 需調整縫線
可能的額外處置	-	約四分之一的人術後需要「針撥」疏通	拆線、針撥、 注射抗疤藥物
主要風險	藥物副作用（口服藥可能手腳麻、腸胃不適、腎結石）	眼壓過低、出血、 支架阻塞	眼壓過低、白內障加速、濾過泡感染（少見但嚴重）
費用	健保	【本院】 自費約 8萬元	健保

重要： 手術的目的是**保住現有視力**，不會讓視力變好。手術後剛開始視力可能暫時模糊。

二、對您來說，什麼比較重要？

1. 每天點眼藥水，對您來說有多麻煩？

☐ 很麻煩，常忘記或覺得困擾　☐ 還可以　☐ 完全沒問題

2. 能不開刀就不開刀，對您有多重要？

☐ 非常重要　☐ 有點重要　☐ 不重要

3. 盡量把眼壓降到最低、保住視力，即使恢復期比較長，您可以接受嗎？

☐ 可以接受　☐ 視情況　☐ 希望恢復快一點

4. 手術後前三個月，每 1–2 週回診一次，對您可行嗎？

☐ 沒問題　☐ 有點困難（需請假或家人接送）　☐ 很困難

5. 對自費手術的接受度

☐ 希望完全使用健保　☐ 可以接受　☐ 效果優先，費用不是主要考量

三、確認一下您的了解

6. 青光眼手術後，視力會比手術前變好。

☐ 對　☐ 不對　☐ 不確定

答題後顯示：**不對。** 手術是為了阻止惡化、保住現有視力。

7. 用了很多種眼藥水，眼壓還是可能無法降到安全範圍。

☐ 對　☐ 不對　☐ 不確定

答題後顯示：**對。** 藥物有極限，這也是此時考慮手術的原因。

四、我的選擇與確認

8. 我目前傾向：

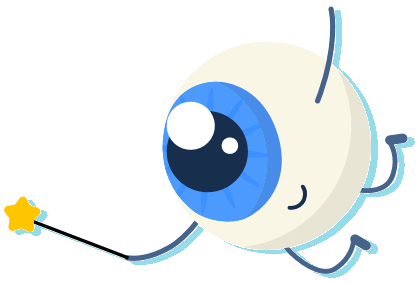
☐ 再加最後一種藥　☐ XEN 凝膠支架　☐ 小樑網切除術　☐ 還沒決定，想再和醫師討論

9. 我對自己的選擇有把握　☐ 是 ☐ 否

10. 我了解每個選項的好處和缺點　☐ 是 ☐ 否

11. 我清楚哪些事情對我最重要　☐ 是 ☐ 否

12. 我有足夠的支持和建議來做決定　☐ 是 ☐ 否



醫師確認： 治療決定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　醫師簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

病人／家屬簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本工具僅供醫病討論使用，不取代醫師的臨床判斷。

版本 v3（草案）

建立日期：2026/10/05

修訂：2026/10/09（SLT 改為健保給付）　預計檢視日期：＿＿＿＿＿＿